Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Revisão Flash · Sessão 08

Queimaduras

O essencial para a prova em uma página

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Queimaduras

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Interrompa a queimadura, dê O2 a 100% e decida cedo sobre a via aérea, some só 2º e 3º graus, reponha Ringer lactato titulando pela diurese e encaminhe quem preenche critério.

1. **Resfriar:** água corrente em temperatura ambiente por 20 min. Nunca gelo.
2. **CO:** oxímetro normal não exclui; pedir carboxi-hemoglobina. O2 a 100% para todos.
3. IOT imediata: rouquidão, estridor, insuficiência respiratória ou rebaixamento sem proteção da via aérea.
4. **SCQ:** só 2º e 3º graus. Mão do paciente, com dedos, vale cerca de 1%.
5. **Regra dos nove:** cabeça 9, cada MS 9, tronco 18 + 18, cada MI 18, períneo 1.
6. **Antes da conta:** RL por idade: 125, 250 ou 500 mL/h.
7. **ATLS 11:** 2 mL × kg × %SCQ ÷ 16 = mL/h no adulto; 3 mL na criança; 4 mL na elétrica.
8. **Parkland:** 4 mL × kg × %SCQ, metade em 8 h a partir da queimadura.

Diurese-alvo

Paciente	mL/kg/h
Adulto	0,5
Criança < 13 anos	1
Elétrica	1 a 1,5

Pegadinha

As 8 horas de Parkland contam **da queimadura**. Chegou após 3 horas? Restam 5, descontado o que já correu.

Checklist antes da prova

- ☐ Diferencio 2º grau superficial e profundo
- ☐ Calculo a SCQ pela regra dos nove
- ☐ Faço a conta do ATLS 11 e a de Parkland
- ☐ Sei a diurese-alvo e como titular
- ☐ Sei quando intubar o queimado
- ☐ Sei os critérios de transferência
- ☐ Sei quando indicar escarotomia